TEST

Josep Manuel Hernández Pérez

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS

Técnico/a en Emergencias Sanitarias- TEL

TEST TEMA 3
Normativa general

I. II Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad

1. El II Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad debe entenderse principalmente como:

A) Una norma penal de protección frente a la violencia de género.
B) Un instrumento de planificación interna basado en diagnóstico, medidas, responsables, indicadores y evaluación.
C) Un reglamento exclusivo para pacientes y personas usuarias.
D) Una instrucción sobre conducción de ambulancias.

2. ¿A qué personal se aplica el II Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad?

A) Solo al personal estatutario fijo.
B) Solo al personal sanitario facultativo.
C) A todo el personal gestionado por la Conselleria, con independencia de que su relación sea estatutaria, funcionarial o laboral.
D) Exclusivamente al personal directivo.

3. La vigencia del actual II Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad es:

A) 2020-2024.
B) 2023-2027.
C) 2017-2021.
D) Indefinida, sin periodo temporal.

4. ¿Por qué una plantilla mayoritariamente feminizada no elimina la necesidad de un plan de igualdad?

A) Porque la igualdad solo se mide por el número total de mujeres.
B) Porque pueden persistir desigualdades en promoción, retribuciones, jefaturas, conciliación, acoso o salud laboral.
C) Porque las mujeres no pueden ocupar puestos directivos.
D) Porque el plan solo afecta a los hombres.

5. La necesidad de datos desagregados por sexo en un plan de igualdad sirve para:

A) Ocultar desigualdades bajo datos globales.
B) Sustituir la evaluación por impresiones subjetivas.
C) Detectar diferencias reales y medir si las medidas adoptadas funcionan.
D) Evitar toda comparación entre mujeres y hombres.

6. El área de transversalidad de la igualdad persigue que:

A) La igualdad se limite a campañas puntuales.
B) La igualdad quede fuera de la gestión ordinaria.
C) La igualdad se incorpore a la organización, protocolos, formación, datos y decisiones habituales.
D) Solo se actúe cuando ya exista una sanción judicial.

7. En materia de selección, provisión y promoción, una medida coherente con el II Plan sería:

A) Eliminar criterios objetivos de selección.
B) Evitar sesgos y atender a situaciones como embarazo, parto o lactancia en los procesos.
C) Dar preferencia automática a cualquier persona por razón de sexo.
D) Impedir la presencia equilibrada en tribunales.

8. La representación equilibrada se relaciona especialmente con:

A) La presencia de mujeres y hombres en órganos, comisiones, jefaturas y puestos de responsabilidad.
B) La supresión de órganos técnicos de selección.
C) La eliminación de la carrera profesional.
D) La sustitución de la formación por antigüedad.

9. El análisis de brecha salarial en el II Plan debe atender, entre otros factores, a:

A) Solo al salario base, sin complementos.
B) Retribuciones, complementos, guardias, disponibilidad, carrera profesional y acceso a puestos mejor remunerados.
C) Únicamente a la edad de la plantilla.
D) Solo a los contratos temporales de verano.

10. La conciliación y corresponsabilidad en el II Plan se orienta a:

A) Hacer recaer los cuidados exclusivamente en las mujeres.
B) Facilitar permisos y organización del tiempo sin penalizar la carrera profesional y promoviendo corresponsabilidad.
C) Suprimir permisos familiares.
D) Condicionar la promoción a la renuncia a permisos.

11. La salud laboral con perspectiva de género exige:

A) Analizar riesgos laborales considerando embarazo, lactancia, acoso, turnos, cargas y violencia externa, entre otros factores.
B) Aplicar siempre idéntica prevención sin valorar situaciones específicas.
C) Excluir los riesgos psicosociales.
D) Limitarse a accidentes de tráfico.

12. El área sobre violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo se vincula principalmente con:

A) La prevención, detección, actuación, movilidad, confidencialidad y formación de mandos y personal.
B) La eliminación de protocolos internos.
C) La publicidad activa de datos de víctimas.
D) La sustitución de servicios sanitarios por órganos judiciales.

13. La formación en igualdad y perspectiva de género dentro del II Plan tiene como finalidad:

A) Reducir la formación del personal al mínimo imprescindible.
B) Capacitar al personal en igualdad, lenguaje no sexista, prevención del acoso y atención con perspectiva de género.
C) Sustituir la formación sanitaria por formación jurídica exclusiva.
D) Formar solo a altos cargos.

14. La investigación con perspectiva de género implica:

A) Ignorar la variable sexo en los estudios.
B) Incorporar sexo y género en datos, estudios y análisis sanitarios cuando resulte relevante.
C) Estudiar solo a mujeres.
D) Eliminar todos los indicadores.

15. El seguimiento del II Plan exige principalmente:

A) Aprobar el plan y no volver a revisarlo.
B) Una comisión de igualdad, indicadores, evaluación periódica y evaluación final.
C) Sustituir indicadores por opiniones.
D) Publicar únicamente el índice del documento.

II. Ley Orgánica 1/2004 de protección integral frente a la violencia de género

16. La Ley Orgánica 1/2004 tiene por objeto principal:

A) Regular únicamente el transporte sanitario.
B) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las víctimas.
C) Regular solo las prestaciones de dependencia.
D) Regular exclusivamente la publicidad activa.

17. Según la LO 1/2004, la violencia de género se refiere a la violencia ejercida contra las mujeres por:

A) Cualquier persona desconocida, en cualquier contexto.
B) Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
C) Exclusivamente familiares de primer grado.
D) Cualquier administración pública.

18. La violencia de género comprendida en la LO 1/2004 incluye:

A) Solo lesiones físicas visibles.
B) Violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad.
C) Solo daños patrimoniales.
D) Exclusivamente discusiones verbales sin relevancia jurídica.

19. La idea de respuesta integral en la LO 1/2004 significa que:

A) Solo interviene el Derecho penal.
B) Intervienen prevención, educación, sanidad, servicios sociales, derechos laborales, tutela institucional y judicial.
C) La víctima debe resolver el problema sin ayuda institucional.
D) Solo se actúa cuando exista sentencia firme.

20. Los planes de sensibilización previstos en la LO 1/2004 se relacionan con:

A) La prevención y concienciación social frente a la violencia de género.

B) La concesión de prestaciones de dependencia.
C) La aprobación de presupuestos locales.
D) La creación de grados de discapacidad.

21. La actuación sanitaria frente a la violencia de género se apoya en la LO 1/2004 porque:

A) La sanidad no tiene papel alguno en la detección.
B) La norma prevé actuaciones sanitarias para detección precoz y asistencia de las víctimas.
C) Solo los juzgados pueden observar lesiones.
D) El personal sanitario debe interrogar como policía judicial.

22. El fomento de la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en información, atención y protección de víctimas es un principio recogido en:

A) La Ley Orgánica 1/2004.
B) La Ley de Propiedad Horizontal.
C) El Código de Comercio.
D) La Ley de Carreteras.

23. El derecho de las víctimas a recibir información se recoge en la LO 1/2004 como:

A) Un derecho accesorio que solo nace si hay condena.
B) Derecho a información sobre medidas de protección, derechos y recursos existentes.
C) Una obligación exclusiva de familiares.
D) Un derecho limitado a personas con contrato laboral.

24. La asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género comprende:

A) Atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, entre otras actuaciones.
B) Solo una ayuda económica automática.
C) Únicamente defensa penal del agresor.
D) Solo traslado en ambulancia.

25. La asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género está contemplada en:

A) La LO 1/2004, dentro de los derechos de las mujeres víctimas.
B) La Ley 39/2006 de dependencia.
C) El II Plan de Igualdad como única fuente.
D) La Ley 3/2019 exclusivamente.

26. Los derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas de violencia de género se regulan en:

A) La LO 1/2004, art. 21.
B) La Ley 19/2013, art. 12.
C) El RDL 1/2013, art. 28.
D) La Ley 39/2006, art. 15.

27. La ayuda económica específica prevista para determinadas víctimas de violencia de género se regula en:

A) LO 1/2004, art. 27.
B) Ley 39/2006, art. 26.
C) Ley 1/2022, art. 34.
D) TREBEP, art. 54.

28. A efectos de reconocer derechos, la situación de violencia de género puede acreditarse mediante:

A) Solo una declaración verbal ante un vecino.
B) Sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial de medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal u otros títulos previstos legalmente.
C) Solo parte de baja laboral.
D) Únicamente informe de una empresa privada.

29. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se relaciona con:

A) La tutela institucional y la formulación, coordinación e impulso de políticas públicas contra la violencia de género.
B) El cálculo de grados de dependencia.
C) La aprobación de facturas sanitarias.
D) La expedición del permiso de conducir.

30. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se vincula con:

A) La recogida, análisis y difusión de información sobre violencia de género y asesoramiento institucional.
B) La gestión de listas de espera sanitarias.
C) La inspección de vehículos de emergencia.
D) La liquidación de impuestos municipales.

31. La coordinación entre administraciones y recursos en violencia de género se articula, entre otros instrumentos, mediante:

A) Planes de colaboración.
B) Contratos privados sin control.
C) El silencio administrativo positivo automático.
D) La supresión de protocolos.

32. En una intervención de emergencias con posible violencia de género, la conducta más ajustada es:

A) Presionar a la víctima para que denuncie en ese momento.
B) Atender, procurar privacidad, registrar objetivamente y coordinar por protocolo.
C) Interrogar como si el TES fuera juez.
D) Comentar el caso con terceros para obtener opiniones.

33. Evitar la revictimización significa:

A) Evitar preguntas innecesarias, juicios, exposición pública o comentarios culpabilizadores.
B) Negarse a atender a la víctima si no denuncia.
C) Divulgar el caso para prevenir a otras personas.
D) Permitir siempre que el presunto agresor conteste por la víctima.

III. Políticas públicas, modelos de decisión, evaluación e indicadores

34. Una política pública es:

A) Una actuación aislada sin responsables ni recursos.
B) Un conjunto organizado de decisiones y actuaciones públicas para afrontar un problema colectivo.
C) Una opinión personal del empleado público.
D) Un documento sin objetivos ni evaluación.

35. El ciclo básico de una política pública suele comenzar por:

A) La mejora final.
B) La identificación de un problema público y su entrada en la agenda.
C) La sanción disciplinaria.
D) La publicación de datos clínicos.

36. La agenda pública se refiere a:

A) El momento en que una necesidad social es reconocida como asunto que requiere actuación institucional.
B) Una simple lista privada de tareas.
C) La fase de archivo de expedientes ya cerrados.
D) El registro de vehículos oficiales.

37. El modelo racional-comprehensivo de decisión se caracteriza por:

A) Elegir sin datos ni alternativas.
B) Identificar alternativas, valorar costes y beneficios y escoger la opción óptima.
C) Cambiar siempre lo mínimo posible.
D) Decidir únicamente por presión social.

38. El modelo incremental consiste en:

A) Modificar políticas existentes paso a paso, sin grandes rupturas.
B) Diseñar siempre desde cero.
C) Eliminar toda evaluación.
D) Actuar solo tras sentencia judicial.

39. La racionalidad limitada o modelo satisfactorio implica:

A) Buscar una alternativa suficiente cuando la información, el tiempo o los recursos son limitados.
B) Disponer de información perfecta siempre.
C) No tomar ninguna decisión.
D) Decidir por sorteo.

40. El modelo participativo de decisión pública aporta principalmente:

A) Mayor legitimidad y conocimiento del problema al incorporar personas y colectivos afectados.
B) Rapidez absoluta sin debate.
C) Supresión de conflictos.
D) Eliminación de indicadores.

41. El modelo mixto o estratégico combina:

A) Análisis técnico, negociación, recursos disponibles y prioridades políticas.
B) Solo intuición.
C) Solo sanciones penales.
D) Únicamente publicidad activa.

42. La diferencia entre diseño e implementación de una política pública es que:

A) Diseñar es concretar qué se hará; implementar es llevarlo a la práctica.
B) Diseñar e implementar significan exactamente lo mismo.
C) Implementar es aprobar la ley y no ejecutarla.
D) Diseñar es evaluar resultados finales.

43. Evaluar una política pública significa:

A) Valorar sistemáticamente si es necesaria, coherente, eficaz, eficiente y útil.
B) Comprobar solo si existe un expediente físico.
C) Sustituir la decisión política por rumores.
D) Eliminar la rendición de cuentas.

44. La evaluación ex ante se realiza:

A) Antes de aprobar o ejecutar la política.
B) Solo al final de la política.
C) Después de diez años siempre.
D) Cuando ya no hay posibilidad de corregir.

45. La evaluación de proceso se realiza:

A) Durante la ejecución para comprobar actividades y desviaciones.
B) Antes de que exista el problema.
C) Solo cuando hay responsabilidad penal.
D) Únicamente sobre facturas.

46. Un indicador es:

A) Una medida que permite observar un fenómeno y comprobar avances o resultados.
B) Una opinión personal sin datos.
C) Un sinónimo de expediente.
D) Un derecho subjetivo de dependencia.

47. Un buen indicador debe ser:

A) Relevante, claro, fiable, comparable, posible de obtener y útil para decidir.
B) Confuso, imposible de medir y no comparable.
C) Secreto y no verificable.
D) Siempre cualitativo y nunca numérico.

48. Un indicador de producto u output mide:

A) Resultados inmediatos, como personas formadas o solicitudes resueltas.
B) Cambios finales a largo plazo.
C) Solo recursos presupuestarios.
D) Opiniones informales de pasillo.

49. Un riesgo frecuente de la evaluación es:

A) Confundir cantidad con calidad y medir solo lo fácil, no lo importante.
B) Usar datos desagregados.
C) Comprobar resultados.
D) Relacionar objetivos e indicadores.

50. La Ley valenciana 1/2022 fomenta una cultura de planificación y evaluación que debe incluir:

A) Diagnosis, metas, objetivos estratégicos y operativos, indicadores y mejora continua.
B) Improvisación, ausencia de objetivos y opacidad.
C) Únicamente expedientes sancionadores.
D) Supresión de la participación.

IV. Ética pública y buen gobierno

51. La ética pública se refiere a:

A) Valores y reglas de conducta que deben guiar a quienes trabajan en la Administración.
B) Una preferencia personal sin relación con el servicio público.
C) Solo la cortesía externa, sin consecuencias.
D) Una materia exclusiva de pacientes.

52. El buen gobierno se centra especialmente en:

A) La forma ética, transparente, planificada y responsable de dirigir instituciones públicas.
B) La ausencia de planificación.
C) El uso de información pública sin límites.
D) La discrecionalidad sin rendición de cuentas.

53. Según el TREBEP, los empleados públicos deben actuar con principios como:

A) Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y respeto a la igualdad.
B) Favoritismo, opacidad y arbitrariedad.
C) Interés privado por encima del general.
D) Uso personal de recursos públicos.

54. Un principio ético básico del empleado público es:

A) Actuar conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
B) Obedecer instrucciones manifiestamente ilegales.
C) Priorizar siempre intereses familiares.
D) Divulgar información sanitaria si resulta llamativa.

55. El trato con atención y respeto a la ciudadanía, superiores y restantes empleados públicos es:

A) Un principio de conducta del personal empleado público.
B) Una recomendación sin respaldo jurídico.
C) Una regla solo para altos cargos.
D) Una obligación únicamente en expedientes sancionadores.

56. Un conflicto de intereses aparece cuando:

A) Un interés personal, familiar, económico o de otro tipo puede comprometer la imparcialidad del deber público.
B) Una persona trabaja con diligencia.
C) Se cumple el horario.
D) Se protege la confidencialidad.

57. Aceptar regalos o ventajas que puedan condicionar la imparcialidad vulnera:

A) La integridad y el deber de servicio al interés general.
B) El principio de accesibilidad.
C) La publicidad activa.
D) La teleasistencia.

58. La confidencialidad en emergencias sanitarias exige:

A) Proteger datos personales y sanitarios y no comentar intervenciones fuera de los cauces profesionales.
B) Publicar imágenes de accidentes si no aparece el nombre.
C) Facilitar datos a cualquier familiar sin comprobar legitimación.
D) Usar mensajería privada para difundir casos.

59. El uso del uniforme, ambulancia o información del servicio en redes sociales para promoción personal puede vulnerar:

A) Integridad, confidencialidad, imagen institucional e intimidad de las personas atendidas.
B) El derecho de acceso a información pública.
C) La prestación económica vinculada al servicio.
D) La racionalidad limitada.

60. En la atención a personas vulnerables, el trato digno implica:

A) Explicar lo posible, adaptar la comunicación, proteger intimidad y evitar comentarios humillantes.
B) Infantilizar siempre a la persona.
C) Ignorar su autonomía.
D) Reducir a la persona a su diagnóstico.

61. La Ley 1/2022 exige a los altos cargos principios como:

A) Integridad, ejemplaridad, transparencia, rendición de cuentas y buena administración.
B) Secreto absoluto de toda actividad pública.
C) Supresión de la evaluación.
D) Actuación sin control jurídico.

62. Los códigos éticos o de conducta previstos por la Ley 1/2022 sirven para:

A) Concretar valores, normas de conducta, principios rectores y política de regalos.
B) Eliminar las obligaciones de transparencia.
C) Sustituir el ordenamiento jurídico.
D) Permitir regalos sin límite.

V. Transparencia en la Administración valenciana

63. La Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana tiene por objeto:

A) Regular publicidad activa, derecho de acceso, reutilización y el Consejo Valenciano de Transparencia, entre otros aspectos.
B) Regular solo permisos laborales.
C) Crear grados de dependencia.
D) Regular exclusivamente la historia clínica.

64. La publicidad activa consiste en:

A) Publicar de oficio información relevante sin esperar a que alguien la solicite.
B) Entregar datos clínicos de pacientes a cualquier ciudadano.
C) Publicar solo cuando lo ordene un juez.
D) Sustituir el derecho de acceso por silencio.

65. El derecho de acceso a la información pública permite:

A) Solicitar información pública sin necesidad de motivar la solicitud ni invocar la ley.
B) Exigir datos sanitarios identificables de cualquier paciente.
C) Entrar en cualquier despacho público.
D) Anular la protección de datos personales.

66. Los criterios generales de publicación de la información en publicidad activa exigen que sea:

A) Veraz, objetiva, actualizada, clara, estructurada, comprensible, accesible y fácilmente localizable.
B) Desordenada, difícil de encontrar y sin actualizar.
C) Exclusivamente en papel.
D) Incomprensible para evitar consultas.

67. La información pública publicada o facilitada debe tratar los datos personales:

A) Conforme a principios de protección de datos, proporcionalidad, minimización y protección desde el diseño y por defecto.
B) Sin límite alguno.
C) Solo si lo pide un medio de comunicación.
D) Siempre publicando nombre y DNI completo.

68. Cuando la publicidad activa contenga datos especialmente sensibles o relativos a menores o personas vulnerables:

A) Debe publicarse sin cambios.
B) Debe anonimizarse para impedir la identificación, salvo previsión legal específica.
C) Debe difundirse por redes sociales.
D) Debe entregarse solo verbalmente.

69. El plazo ordinario para resolver y notificar una solicitud de acceso a información pública en la Ley 1/2022 es:

A) Diez días naturales.
B) Un mes desde la entrada de la solicitud en el registro competente.
C) Seis meses siempre.
D) No existe plazo.

70. Si el volumen o complejidad de la información lo requiere, el plazo para resolver una solicitud de acceso puede:

A) Prorrogarse por un mes más mediante resolución motivada.
B) Prorrogarse indefinidamente sin motivación.
C) Reducirse siempre a 24 horas.
D) Convertirse en un expediente de dependencia.

71. Transcurrido el plazo máximo sin resolución en una solicitud de acceso, la Ley 1/2022 establece que:

A) La solicitud se considera estimada automáticamente.
B) La solicitud se considera desestimada a efectos de recurso o reclamación.
C) Se publican todos los datos solicitados.
D) La Administración queda exenta de resolver.

72. Los límites al derecho de acceso deben aplicarse:

A) De manera proporcional, motivada y restrictiva en beneficio del derecho de acceso.
B) Automáticamente para negar cualquier solicitud.
C) Sin motivar.
D) Solo por preferencia política.

73. Cuando solo una parte de la información está afectada por un límite, procede en principio:

A) Facilitar acceso parcial, omitiendo la parte afectada si no distorsiona la información.
B) Denegar siempre toda la solicitud.
C) Publicar datos personales completos.
D) Destruir el expediente.

74. El Consejo Valenciano de Transparencia es:

A) La autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana.
B) Un órgano judicial penal.
C) Un servicio de ambulancias.
D) Una comisión de igualdad interna sanitaria.

75. Una función del Consejo Valenciano de Transparencia es:

A) Resolver reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso a la información pública.
B) Reconocer grados de dependencia.
C) Autorizar traslados sanitarios.
D) Aprobar protocolos clínicos.

76. Las unidades de transparencia y participación en cada departamento del Consell tienen como finalidad:

A) Coordinar actuaciones en transparencia, acceso a información pública, datos abiertos y participación.
B) Suprimir el portal de transparencia.
C) Gestionar exclusivamente nóminas.
D) Resolver procedimientos penales.

77. En sanidad, transparencia pública y confidencialidad asistencial se relacionan así:

A) Son compatibles: se informa sobre actividad pública, pero se protegen datos de salud e intimidad.
B) La transparencia permite publicar cualquier historia clínica.
C) La confidencialidad elimina toda transparencia institucional.
D) La publicidad activa sustituye al secreto profesional.

78. La planificación estratégica en materia de transparencia en la Generalitat se prevé para:

A) Programar, implantar, seguir y mejorar las actuaciones de transparencia.
B) Eliminar la publicidad activa.
C) Evitar la evaluación.
D) Sustituir el Consejo Valenciano de Transparencia.

VI. Dependencia y diversidad funcional

79. La Ley 39/2006 tiene por objeto:

A) Regular condiciones básicas del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia mediante el SAAD.
B) Regular únicamente la violencia de género.
C) Regular solo la transparencia autonómica.
D) Regular la ética de altos cargos.

80. La dependencia se define legalmente como:

A) Estado permanente en que, por edad, enfermedad o discapacidad y pérdida de autonomía, se precisan apoyos para actividades básicas o autonomía personal.
B) Una situación económica coyuntural sin relación con apoyos.
C) Una discapacidad reconocida automáticamente.
D) Un expediente de transparencia.

81. Las actividades básicas de la vida diaria incluyen:

A) Tareas elementales como cuidado personal, movilidad esencial, actividades domésticas básicas u orientación.
B) Solo actividades deportivas.
C) Únicamente gestiones bancarias complejas.
D) Solo conducir vehículos.

82. Entre los principios de la Ley 39/2006 se encuentra:

A) La atención integral e integrada y la colaboración de servicios sociales y sanitarios.
B) La exclusión de la iniciativa pública.
C) La ausencia de perspectiva de género.
D) La imposibilidad de permanencia en el entorno habitual.

83. Las personas en situación de dependencia tienen derecho, entre otros, a:

A) Respeto de su dignidad e intimidad e información completa en términos comprensibles y accesibles.
B) Que sus datos se divulguen por interés general.
C) No participar nunca en decisiones.
D) Perder todos los derechos por necesitar apoyo.

84. Son titulares de derechos de la Ley 39/2006 quienes, cumpliendo requisitos, se encuentren:

A) En situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
B) En situación de conflicto laboral.
C) Solicitando información pública sobre contratos.
D) En cualquier situación sin requisitos.

85. Los grados de dependencia son:

A) Grado I moderada, Grado II severa y Grado III gran dependencia.
B) Leve, media y alta sin regulación.
C) A, B y C.
D) Inicial, intermedio y final.

86. La valoración de la dependencia se realiza mediante:

A) Órganos de valoración autonómicos y baremo aprobado conforme al sistema legal.
B) Opinión informal de vecinos.
C) Decisión del conductor de la ambulancia.
D) Autodeclaración sin procedimiento.

87. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectúa mediante resolución de:

A) La Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante.
B) La empresa privada que presta el servicio.
C) El juzgado de violencia sobre la mujer.
D) El Consejo Valenciano de Transparencia.

88. El Programa Individual de Atención (PIA) sirve para:

A) Determinar las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de la persona.
B) Imponer una sanción administrativa.
C) Publicar datos de salud.
D) Sustituir la valoración de grado.

89. El catálogo de servicios de dependencia incluye, entre otros:

A) Prevención y promoción de autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día/noche y atención residencial.
B) Solo una prestación económica única.
C) Únicamente transporte privado.
D) Exclusivamente asistencia jurídica.

90. El grado de dependencia y la prestación reconocida pueden revisarse por:

A) Mejoría o empeoramiento de la situación, error de diagnóstico o aplicación del baremo, entre otras causas.
B) Simple cambio de opinión de un tercero sin procedimiento.
C) Solicitud de información pública.
D) La mera publicación del plan de igualdad.

91. La discapacidad, según el RDL 1/2013, resulta de:

A) La interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras que limitan la participación plena y efectiva.
B) Una incapacidad absoluta automática.
C) La edad por sí sola.
D) Una situación de dependencia siempre idéntica.

92. Entre los principios del RDL 1/2013 están:

A) Dignidad, autonomía individual, vida independiente, no discriminación, igualdad de oportunidades e igualdad entre mujeres y hombres.
B) Segregación, aislamiento y trato paternalista.
C) Opacidad y ausencia de apoyos.
D) Exclusión de la participación social.

93. El derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad implica:

A) Atención sin discriminación por discapacidad y coordinación social y sanitaria cuando sea necesaria.
B) Atención solo si la persona no tiene apoyos.
C) Exclusión de la salud mental.
D) Publicación de datos clínicos.

94. El respeto a la autonomía de las personas con discapacidad exige que:

A) La información y el consentimiento se faciliten en formatos adecuados, accesibles y comprensibles.
B) Siempre decidan terceros sin escuchar a la persona.
C) La persona no reciba información.
D) Se prescinda de apoyos para la toma de decisiones.

95. El derecho a la igualdad de las personas con discapacidad comporta que:

A) Tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos y las administraciones deben promover medidas para hacerlos reales y efectivos.
B) Solo tienen derechos si viven en centros residenciales.
C) La igualdad se logra ignorando barreras.
D) No procede acción positiva en ningún caso.

96. La accesibilidad universal se vincula con:

A) Entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos e instrumentos comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y autonomía.
B) La eliminación de ajustes razonables.
C) La publicación de documentos ilegibles.
D) La sustitución del consentimiento informado.

97. Las relaciones con las Administraciones Públicas deben cumplir condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en:

A) Oficinas, dispositivos, servicios de atención ciudadana y participación pública.
B) Solo medios de transporte privados.
C) Exclusivamente locales de ocio.
D) Únicamente contratos mercantiles.

98. Los ajustes razonables son:

A) Adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan carga desproporcionada para garantizar igualdad de las personas con discapacidad.
B) Un trato de favor injustificado.
C) Una sanción disciplinaria.
D) Un trámite de transparencia.

99. La Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana configura el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como:

A) Un sistema orientado a derechos sociales, inclusión, autonomía, apoyo y protección frente a vulnerabilidad, dependencia o urgencia social.
B) Un sistema privado sin responsabilidad pública.
C) Un régimen penal especial.
D) Un sistema exclusivamente sanitario.

100. La diferencia principal entre dependencia y discapacidad/diversidad funcional es que:

A) La dependencia valora necesidad de ayuda para actividades básicas y autonomía; la discapacidad se relaciona con barreras, derechos, accesibilidad e inclusión.
B) Son exactamente el mismo procedimiento.
C) La discapacidad siempre implica gran dependencia.
D) La dependencia nunca requiere apoyos.

Test Soluciones

Josep Manuel Hernández Pérez

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS

Tabla final de respuestas

La columna de referencia indica el artículo de la norma cuando existe un precepto concreto. En el II Plan de Igualdad se cita el área, apartado o bloque del plan, ya que no está estructurado en artículos. En los modelos de decisión y algunos conceptos de evaluación se cita la materia doctrinal del tema, sin perjuicio de su conexión con la Ley 1/2022 cuando procede.

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / norma o referencia
1	B) Un instrumento de planificación interna basado en diagnóstico, medidas, responsables, indicadores y evaluación.	II Plan de Igualdad 2023-2027, introducción, diagnóstico, áreas de intervención, indicadores y seguimiento.
2	C) A todo el personal gestionado por la Conselleria, con independencia de que su relación sea estatutaria, funcionarial o laboral.	II Plan de Igualdad 2023-2027, ámbito de aplicación.
3	B) 2023-2027.	II Plan de Igualdad 2023-2027, vigencia.
4	B) Porque pueden persistir desigualdades en promoción, retribuciones, jefaturas, conciliación, acoso o salud laboral.	II Plan de Igualdad 2023-2027, diagnóstico de situación y brecha salarial/jefaturas.
5	C) Detectar diferencias reales y medir si las medidas adoptadas funcionan.	II Plan de Igualdad 2023-2027, diagnóstico e indicadores.
6	C) La igualdad se incorpore a la organización, protocolos, formación, datos y decisiones habituales.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 1, integración transversal de la igualdad.
7	B) Evitar sesgos y atender a situaciones como embarazo, parto o lactancia en los procesos.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 2, selección, provisión y promoción.
8	A) La presencia de mujeres y hombres en órganos, comisiones, jefaturas y puestos de responsabilidad.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 3, representación equilibrada.
9	B) Retribuciones, complementos, guardias, disponibilidad, carrera profesional y acceso a puestos mejor remunerados.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 4, retribuciones y brecha salarial.
10	B) Facilitar permisos y organización del tiempo sin penalizar la carrera profesional y promoviendo corresponsabilidad.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 5, conciliación y corresponsabilidad.
11	A) Analizar riesgos laborales considerando embarazo, lactancia, acoso, turnos, cargas y violencia externa, entre otros factores.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 6, salud laboral con perspectiva de género.
12	A) La prevención, detección, actuación, movilidad, confidencialidad y formación de mandos y personal.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 7, violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo.
13	B) Capacitar al personal en igualdad, lenguaje no sexista, prevención del acoso y atención con perspectiva de género.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 8, formación en igualdad y perspectiva de género.
14	B) Incorporar sexo y género en datos, estudios y análisis sanitarios cuando resulte relevante.	II Plan de Igualdad 2023-2027, Área 9, investigación con perspectiva de género.
15	B) Una comisión de igualdad, indicadores, evaluación periódica y evaluación final.	II Plan de Igualdad 2023-2027, comisión de igualdad, indicadores, seguimiento y evaluación.
16	B) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las víctimas.	Ley Orgánica 1/2004, art. 1.
17	B) Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.	Ley Orgánica 1/2004, art. 1.1.
18	B) Violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad.	Ley Orgánica 1/2004, art. 1.3.
19	B) Intervienen prevención, educación, sanidad, servicios sociales, derechos laborales, tutela institucional y judicial.	Ley Orgánica 1/2004, arts. 1 y 2.
20	A) La prevención y concienciación social frente a la violencia de género.	Ley Orgánica 1/2004, art. 3.
21	B) La norma prevé actuaciones sanitarias para detección precoz y asistencia de las víctimas.	Ley Orgánica 1/2004, art. 15.
22	A) La Ley Orgánica 1/2004.	Ley Orgánica 1/2004, art. 2.j.
23	B) Derecho a información sobre medidas de protección, derechos y recursos existentes.	Ley Orgánica 1/2004, art. 18.
24	A) Atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, entre otras actuaciones.	Ley Orgánica 1/2004, art. 19.
25	A) La LO 1/2004, dentro de los derechos de las mujeres víctimas.	Ley Orgánica 1/2004, art. 20.
26	A) La LO 1/2004, art. 21.	Ley Orgánica 1/2004, art. 21.
27	A) LO 1/2004, art. 27.	Ley Orgánica 1/2004, art. 27.

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / norma o referencia
28	B) Sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial de medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal u otros títulos previstos legalmente.	Ley Orgánica 1/2004, art. 23.
29	A) La tutela institucional y la formulación, coordinación e impulso de políticas públicas contra la violencia de género.	Ley Orgánica 1/2004, art. 29.
30	A) La recogida, análisis y difusión de información sobre violencia de género y asesoramiento institucional.	Ley Orgánica 1/2004, art. 30.
31	A) Planes de colaboración.	Ley Orgánica 1/2004, art. 32.
32	B) Atender, procurar privacidad, registrar objetivamente y coordinar por protocolo.	Ley Orgánica 1/2004, arts. 15, 18 y 19; protocolos sanitarios aplicables.
33	A) Evitar preguntas innecesarias, juicios, exposición pública o comentarios culpabilizadores.	Ley Orgánica 1/2004, arts. 18 y 19; principio de asistencia integral y trato adecuado.
34	B) Un conjunto organizado de decisiones y actuaciones públicas para afrontar un problema colectivo.	Materia doctrinal del Tema 3: políticas públicas, concepto. Ley 1/2022, art. 63, cultura de planificación y evaluación.
35	B) La identificación de un problema público y su entrada en la agenda.	Materia doctrinal del Tema 3: ciclo de políticas públicas.
36	A) El momento en que una necesidad social es reconocida como asunto que requiere actuación institucional.	Materia doctrinal del Tema 3: entrada en la agenda pública.
37	B) Identificar alternativas, valorar costes y beneficios y escoger la opción óptima.	Materia doctrinal del Tema 3: modelos de decisión.
38	A) Modificar políticas existentes paso a paso, sin grandes rupturas.	Materia doctrinal del Tema 3: modelo incremental.
39	A) Buscar una alternativa suficiente cuando la información, el tiempo o los recursos son limitados.	Materia doctrinal del Tema 3: racionalidad limitada.
40	A) Mayor legitimidad y conocimiento del problema al incorporar personas y colectivos afectados.	Materia doctrinal del Tema 3: modelo participativo.
41	A) Análisis técnico, negociación, recursos disponibles y prioridades políticas.	Materia doctrinal del Tema 3: modelo mixto o estratégico.
42	A) Diseñar es concretar qué se hará; implementar es llevarlo a la práctica.	Materia doctrinal del Tema 3: diseño e implementación.
43	A) Valorar sistemáticamente si es necesaria, coherente, eficaz, eficiente y útil.	Ley 1/2022, art. 63; materia doctrinal de evaluación de políticas públicas.
44	A) Antes de aprobar o ejecutar la política.	Materia doctrinal del Tema 3: tipos de evaluación.
45	A) Durante la ejecución para comprobar actividades y desviaciones.	Materia doctrinal del Tema 3: evaluación de proceso.
46	A) Una medida que permite observar un fenómeno y comprobar avances o resultados.	Ley 1/2022, art. 63; materia doctrinal de indicadores.
47	A) Relevante, claro, fiable, comparable, posible de obtener y útil para decidir.	Materia doctrinal del Tema 3: requisitos de indicadores.
48	A) Resultados inmediatos, como personas formadas o solicitudes resueltas.	Materia doctrinal del Tema 3: tipos de indicadores.
49	A) Confundir cantidad con calidad y medir solo lo fácil, no lo importante.	Materia doctrinal del Tema 3: riesgos en la evaluación.
50	A) Diagnosis, metas, objetivos estratégicos y operativos, indicadores y mejora continua.	Ley 1/2022, art. 63.
51	A) Valores y reglas de conducta que deben guiar a quienes trabajan en la Administración.	TREBEP, arts. 52 a 54; Ley 1/2022, arts. 54 y 55.
52	A) La forma ética, transparente, planificada y responsable de dirigir instituciones públicas.	Ley 1/2022, art. 54; Ley 19/2013, título II.
53	A) Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y respeto a la igualdad.	TREBEP, art. 52.
54	A) Actuar conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.	TREBEP, art. 53.1.
55	A) Un principio de conducta del personal empleado público.	TREBEP, art. 54.1.
56	A) Un interés personal, familiar, económico o de otro tipo puede comprometer la imparcialidad del deber público.	TREBEP, art. 53; Ley 1/2022, art. 54.
57	A) La integridad y el deber de servicio al interés general.	TREBEP, arts. 52 y 53; Ley 1/2022, art. 55.
58	A) Proteger datos personales y sanitarios y no comentar intervenciones fuera de los cauces profesionales.	TREBEP, art. 52; Ley 1/2022, art. 9; normativa de protección de datos.
59	A) Integridad, confidencialidad, imagen institucional e intimidad de las personas atendidas.	TREBEP, arts. 52 a 54; Ley 1/2022, art. 9.
60	A) Explicar lo posible, adaptar la comunicación, proteger intimidad y evitar comentarios humillantes.	TREBEP, art. 54.1; Ley 39/2006, art. 4; RDL 1/2013, arts. 6 y 7.
61	A) Integridad, ejemplaridad, transparencia, rendición de cuentas y buena administración.	Ley 1/2022, art. 54.
62	A) Concretar valores, normas de conducta, principios rectores y política de regalos.	Ley 1/2022, art. 55.

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / norma o referencia
63	A) Regular publicidad activa, derecho de acceso, reutilización y el Consejo Valenciano de Transparencia, entre otros aspectos.	Ley 1/2022, art. 1.
64	A) Publicar de oficio información relevante sin esperar a que alguien la solicite.	Ley 1/2022, arts. 10 y 11; Ley 19/2013, arts. 5 a 8.
65	A) Solicitar información pública sin necesidad de motivar la solicitud ni invocar la ley.	Ley 1/2022, art. 27.
66	A) Veraz, objetiva, actualizada, clara, estructurada, comprensible, accesible y fácilmente localizable.	Ley 1/2022, art. 11.
67	A) Conforme a principios de protección de datos, proporcionalidad, minimización y protección desde el diseño y por defecto.	Ley 1/2022, art. 9.
68	B) Debe anonimizarse para impedir la identificación, salvo previsión legal específica.	Ley 1/2022, art. 11.7.
69	B) Un mes desde la entrada de la solicitud en el registro competente.	Ley 1/2022, art. 34.1.
70	A) Prorrogarse por un mes más mediante resolución motivada.	Ley 1/2022, art. 34.2.
71	B) La solicitud se considera desestimada a efectos de recurso o reclamación.	Ley 1/2022, art. 34.3.
72	A) De manera proporcional, motivada y restrictiva en beneficio del derecho de acceso.	Ley 1/2022, art. 28; Ley 19/2013, art. 14.
73	A) Facilitar acceso parcial, omitiendo la parte afectada si no distorsiona la información.	Ley 1/2022, art. 29.
74	A) La autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana.	Ley 1/2022, art. 47.
75	A) Resolver reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso a la información pública.	Ley 1/2022, art. 48.
76	A) Coordinar actuaciones en transparencia, acceso a información pública, datos abiertos y participación.	Ley 1/2022, art. 45.
77	A) Son compatibles: se informa sobre actividad pública, pero se protegen datos de salud e intimidad.	Ley 1/2022, arts. 9, 11 y 28; Ley 19/2013, art. 15.
78	A) Programar, implantar, seguir y mejorar las actuaciones de transparencia.	Ley 1/2022, art. 46.
79	A) Regular condiciones básicas del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia mediante el SAAD.	Ley 39/2006, art. 1.
80	A) Estado permanente en que, por edad, enfermedad o discapacidad y pérdida de autonomía, se precisan apoyos para actividades básicas o autonomía personal.	Ley 39/2006, art. 2.2.
81	A) Tareas elementales como cuidado personal, movilidad esencial, actividades domésticas básicas u orientación.	Ley 39/2006, art. 2.3.
82	A) La atención integral e integrada y la colaboración de servicios sociales y sanitarios.	Ley 39/2006, art. 3.
83	A) Respeto de su dignidad e intimidad e información completa en términos comprensibles y accesibles.	Ley 39/2006, art. 4.
84	A) En situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.	Ley 39/2006, art. 5.
85	A) Grado I moderada, Grado II severa y Grado III gran dependencia.	Ley 39/2006, art. 26.
86	A) Órganos de valoración autonómicos y baremo aprobado conforme al sistema legal.	Ley 39/2006, art. 27.
87	A) La Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante.	Ley 39/2006, art. 28.
88	A) Determinar las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de la persona.	Ley 39/2006, art. 29.
89	A) Prevención y promoción de autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día/noche y atención residencial.	Ley 39/2006, art. 15.
90	A) Mejoría o empeoramiento de la situación, error de diagnóstico o aplicación del baremo, entre otras causas.	Ley 39/2006, art. 30.
91	A) La interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras que limitan la participación plena y efectiva.	RDL 1/2013, art. 2.a.
92	A) Dignidad, autonomía individual, vida independiente, no discriminación, igualdad de oportunidades e igualdad entre mujeres y hombres.	RDL 1/2013, art. 3.
93	A) Atención sin discriminación por discapacidad y coordinación social y sanitaria cuando sea necesaria.	RDL 1/2013, art. 10.
94	A) La información y el consentimiento se faciliten en formatos adecuados, accesibles y comprensibles.	RDL 1/2013, art. 6.

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / norma o referencia
95	A) Tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos y las administraciones deben promover medidas para hacerlos reales y efectivos.	RDL 1/2013, art. 7.
96	A) Entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos e instrumentos comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y autonomía.	RDL 1/2013, art. 2.k y art. 22.
97	A) Oficinas, dispositivos, servicios de atención ciudadana y participación pública.	RDL 1/2013, art. 28.
98	A) Adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan carga desproporcionada para garantizar igualdad de las personas con discapacidad.	RDL 1/2013, art. 2.m.
99	A) Un sistema orientado a derechos sociales, inclusión, autonomía, apoyo y protección frente a vulnerabilidad, dependencia o urgencia social.	Ley 3/2019, arts. 1 y 5.
100	A) La dependencia valora necesidad de ayuda para actividades básicas y autonomía; la discapacidad se relaciona con barreras, derechos, accesibilidad e inclusión.	Ley 39/2006, arts. 2 y 26; RDL 1/2013, arts. 2 y 3.

Fuentes utilizadas

- II Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad 2023-2027.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
- Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, sobre reconocimiento del grado de dependencia y acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas en la Comunitat Valenciana.
- Documento de estudio aportado: Tema 3 Normativa General TES Valencia.